

Púrpuras

Bibliografía 2019 – Hospital Perrupato – Dr. Navarro David
PRONAP 2004

Pueden ser consecuencia de trastornos plaquetarios cuanti o cualitativos o trastornos capilares.

Clasificación

TROMBOCITOPENICAS	Por aumento de destrucción	a. Congénitas	- Púrpura Neonatal Alloinmune - Púrpuras Familiares (Wiskott-Aldrich, Bernard Soulier, May-Hegglin) - Infección intrauterina (VIH, Toxoplasmosis) - Secundarias a Enfermedad Materna (drogas, LES, infecciones, etc.) - Púrpura Trombocitopénica Idiopática (PTI)
		b. Adquiridas	- Púrpura Trombocitopénica Trombótica (PTT) - Púrpura postransfusional - Hiperesplenismo - Secundarias a: • Microangiopatía trombótica (Síndrome urémico hemolítico, coagulación intravascular diseminada, hemangioma gigante) • Anemia hemolítica autoinmune (Síndrome de Evans) • Anemia megaloblástica • Infecciones • Drogas • Colagenopatías • Tumores
	Por disminución de síntesis	a. Congénitas	- Púrpura Trombocitopénica Amegacariocítica genética - Trombocitopenia asociada a ausencia de radio (TAR) - Secundaria a: • Drogas maternas (tiazidas, estrógenos, alcohol) • Infección intrauterina (rubéola, citomegalovirus) • Infecciones severas • Anemia de Fanconi • Enfermedades metabólicas
		b. Adquiridas	- Secundaria a: • Invasión medular (leucemias, linfomas, tumores) • Aplasia medular • Drogas • Radiaciones • Infecciones severas
NO TROMBOCITOPENICAS	De causa plaquetaria: trombocitopatías	a. Congénitas	- Tromboastenia de Glanzsman - Síndrome del Pool de depósito - Parálisis secretoria - Síndrome de plaqueta gris - Síndrome de Wiskott-Aldrich - Síndrome de Bernard-Soulier - Síndrome de Chediak-Higashi - Enfermedad de von Willebrand
		b. Adquiridas	- Intraplaquetarias: Síndromes mieloproliferativos, anemia perniciosa - Extraplaquetarias: Drogas (AAS, dipiridamol), Disproteinemias, hepatopatías, insuficiencia renal
	De causa vascular	a. Congénitas	- Telangiectasia hemorrágica hereditaria (Rendu-Osler) - Pseudoxantoma elástico
		b. Adquiridas	- Síndrome de Schonlein-Henoch - Síndrome de Kawasaki - Poliarteritis nodosa - Hemosiderosis pulmonar idiopática - Secundaria a infecciones virales
	De causa mixta	a. Congénitas:	- Osteogénesis imperfecta - Enfermedad de Ehler-Danlos - Síndrome de Marfan - Pseudoxantoma elástico
		b. Adquiridas:	- Escorbuto
	Trastornos de la coagulación	a. Déficit de proteínas C y S	- Son glicoproteínas dependientes de la vitamina K con propiedades antitrombóticas y profibrinolíticas
		b. Coagulopatías hereditarias	- Hemofilia clásica (déficit de factor VIII) - Enfermedad de Christmas (déficit de factor IX)

Manifestaciones clínicas

- Petequias y hematomas, acompañadas o no de sangrado por mucosas y por otros órganos (epistaxis, etc.)
- Hematomas fáciles frente a traumatismos mínimos, o epistaxis reiteradas, o sangrado repetido por encías al cepillarse los dientes.
- Hallazgo incidental durante un estudio solicitado por otros motivos

Anamnesis

- Forma de aparición (brusca o insidiosa)
- Antecedente de enfermedad en las semanas precedentes
- Administración de medicamentos (aspirina, antibióticos, etc.)
- Presencia de fiebre u otros síntomas generales (pérdida de peso, decaimiento, anorexia, artralgias, etc.)
- Antecedentes de sangrado en el paciente y familiares directos

Examen físico

- Estado general
- Presencia de hepato y/o esplenomegalia y/o adenomegalias

Presunción diagnóstica

- Niño hasta ese momento sano + petequias y sangrado: PTI
- Niño febril + enfermedad aguda + compromiso del estado general + petequias: meningococcemia.
- Niño pequeño + catarro + administración aspirina + petequias diseminadas: púrpura no trombocitopénica secundaria a causa vascular (por acción del virus sobre el endotelio) o a causa plaquetaria (acción antiagregante del AAS).
- Niño con hematomas de localización a franco predominio en miembros (especialmente inferiores) + artralgias (con o sin tumefacción articular) y/o dolor abdominal: Púrpura de Schonlein-Henoch.
- Antecedentes de sangrado en familiares: púrpura de causa hereditaria

Métodos de estudio

1. Hemograma con recuento de plaquetas. Sirve para:

- a) Establecer si la púrpura es secundaria a trombocitopenia.
- b) Comprobar si las otras líneas celulares (hematíes y leucocitos) están o no alteradas.
- c) Determinar tamaño plaquetario, ya sea por la observación del frotis o mediante la medida del volumen plaquetario medio (VPM) en contadores automáticos. El tamaño plaquetario solo puede ser determinado por contadores automáticos altamente confiables (que no son los habitualmente usados en las guardias) o por hematólogos.
- d) Observar si existen alteraciones morfológicas en las células sanguíneas (por ejemplo, inclusiones citoplasmáticas en los neutrófilos).

2. Tiempo de sangría

Investiga fundamentalmente actividad plaquetaria, estando alterado tanto en las trombocitopenias como en los trastornos de funcionalismo plaquetario.

Valor normal en lactantes y niños es de 3 a 9 minutos, en recién nacidos (RN) puede estar ligeramente acortado

3. Prueba del lazo

Investiga tanto actividad plaquetaria como del endotelio vascular. Por lo tanto, su utilidad es muy limitada.

4. Retracción del coagulo

Es un indicador de actividad plaquetaria, estando alterado tanto en los trastornos cuantitativos como en los cualitativos.

5. Medulograma:

Sirve para observar cantidad y morfología de los megacariocitos, así como para descartar la existencia de patologías infiltrativas de médula ósea (leucemias, tumores, etc.)

6. Adhesividad y agregometría plaquetarias:

Son estudios altamente especializados que investigan todos los aspectos del funcionalismo plaquetario.

Están indicados especialmente en

7. Anticuerpos antiplaquetarios

Diagnóstico diferencial

ESTUDIO	TROMBOCITOPENICAS		NO TROMBOCITOPENICAS	
	Destrucción aumentada	Síntesis disminuida	Causa plaquetaria	Causa vascular
Recuento plaquetario	Disminuido	Disminuido	Normal	Normal
Macro/Megaplaquetas	Sí	No	No/Sí	No
Megacariocitos	Aumentados/ Normales	Disminuidos	Normales	Normales
Tiempo de sangría	Prolongado	Prolongado	Prolongado	Normal/Prolongado
Prueba del lazo	Positiva	Positiva	Positiva/Negativa	Positiva/Negativa
Retracción del coágulo	Deficiente	Deficiente	Deficiente/Normal	
Adhesividad y Agregometría	Normal/Deficiente	Normal	Deficiente	Normal
Anticuerpos antiplaquetarios	Positivo/Negativo	Negativo	Negativo	Negativo

Clasificación morfológica de acuerdo con su tamaño:

- < 2 mm: petequias
- 1 cm: equimosis, y las
- Tamaño intermedio: púrpura propiamente dicha, que puede ser palpable (generalmente indica la existencia de vasculitis) o no palpable